

Fecha Última Actualización: 09-03-2023 13:54:36

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Esmeralda Del Carmen Carmona Solís
Edad : 67a 7m 1d
Dirección : Pasaje Ecuador 068

Rut : 7.947.886-5
Fecha Nacto: 08/08/1955
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A097602
Sexo : Femenino
Teléfono : 228508167

N° Epicrisis
338050

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 09/11/2022 19:14

Días Estadía: 120

Unidad de Egreso : Medicina Agudos 2° Piso

Fecha Egreso : 09/03/2023 12:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 09/11/22
FI UCI: 10/11/22
FI UTIM: 20/02/23
FI Sala 01/03/23

ANTECEDENTES:

- Mórvidos: Monorrena derecho por cáncer renal izquierdo operado. EPOC. HTA. Artritis reumatoide. Bocio multinodular con 2 nódulos de alto riesgo de malignidad. Quistes anexiales simples.
- Quirúrgicos: apendicectomía, colecistectomía, nefrectomía izquierda (2004), drenaje perineal (2018), histerectomía por miomas.
- Fármacos: AAS 100 mg, amitriptilina 12.5 mg, atorvastatina 10 mg, leflunomida 20 mg, omeprazol 20 mg, prednisona 5 mg día por medio, valsartán 160 mg.
- Alergias: niega
- Hábitos: TBQ suspendido, OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: No
- Social: Desconocido
- Inmunizaciones: No, rechaza.

HISTORIA DE INGRESO:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de 2 días de evolución de fiebre hasta 39° asociado a CEG, dolor abdominal, vómitos y diarrea. El día de la consulta refiere tope inspiratorio y disnea por lo que acude a servicio de urgencias. Ingresa en malas condiciones, mal perfundida con livideces hasta abdomen, con uso de musculatura accesoria. Se reanima con volumen y luego DVA, se inicia ertapenem + vancomicina y se intuba y conecta a VMI con parámetros protectores. De sus exámenes de ingreso destaca lactato en 137 mg/dL, parámetros inflamatorios elevados (GB 19130, PCR 676), falla renal (crea 4.98, BUN 45), coagulopatía (INR 1.39, TTPA 50) y acidosis metabólica severa (pH 6.85, CO2 33, BIC 5.8). AngioTAC sin TEP, destaca focos de condensación bibasales mayor a derecha, enfisema centroacinar conocido. Ingresa a UCI para continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

1.Shock séptico de foco pulmonar + FOM

Fecha Epicrisis : 09/03/2023 13:54

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 09-03-2023 13:54:36

Página 2 de 4

- a. Disfunción hemodinámica, renal, respiratoria y coagulopatía.
- b. NAC
- 2. Insuficiencia respiratoria
 - a. IOT 09/11/22
- 3. AKI KDIGO III anúrico
- 4. IAM tipo II
- 5. Antecedentes

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN:

1. Hemodinamia: Durante estadía en UCI con requerimientos de DVA en dosis moderadas-altas en relación a hits infecciosos. Bajos requerimientos de sedación, suspendida al momento de traslado a UTIM, donde evoluciona favorablemente, con reinicio de VDO habituales, sin quiebre hemodinámico.

2. Respiratoria: Ventilada con parámetros protectores. Se extuba el 21/11, con salida a VMNI. En contexto de descarga séptica se compromete de conciencia y se deteriora mecánica ventilatoria por lo que se re-intuba el 25/11. Presenta extubación fallida el 09/12 y el 11/12 con re-intubación precoz por la misma causa, requiriendo en dicha oportunidad BNM, suspendido 28/12. Weaning prolongado, con 3 extubaciones fallidas, por lo que se realiza TQT quirúrgica el 06/01 con TQT 7.5. Desde entonces en entrenamiento pulmonar, realizando ventanas del ventilador con regular tolerancia dado miopatía. Inicia ventanas de TQT a filtro el 07/02. Evoluciona favorablemente en UTIM logrando ser decanulada el 27/02 sin incidentes. Evoluciona con requerimientos bajos de O2 hasta la suspensión el 02/03.

3. Infeccioso: Múltiples hits infecciosos, a saber:

- Cobertura inicial empírica con ampicilina/sulbactam, no se aísla microbiología. Evolución inicial favorable pero luego febril, por lo que se escala a Imipenem por 5 días.
- Descarga séptica, se inicia tratamiento de segunda línea con meropenem + vancomicina, esta última suspendida precozmente, completa 10 días de meropenem empíricamente.
- Nuevamente febril, se inicia meropenem + vancomicina, destaca crecimiento de *E. faecium* en HC y se rota a linezolid (pese a ser sensible a vancomicina). Destaca además crecimiento *S. marcescens* en CAET. Respuesta clínica favorable, con OC inflamatoria, se administra amikacina empírica para cubrir foco.
- Pese a cobertura amplia presenta nuevo deterioro clínico con compromiso hemodinámico, se aísla solamente *C. tropicalis* en orina por lo que, ante gravedad, se sospecha candidiasis invasora y se inicia anidulafungina, suspendiendo resto de terapia.
- Nuevo hit infeccioso, HC (+) para *Serratia marcescens*, se inicia empírico Imipenem + colistín, se suspende este último con antibiograma y se asocia con amikacina por 5 días, manteniéndose posteriormente con monoterapia.
- Nueva alza de parámetros inflamatorios en contexto de *S. haemolyticus* en punta de CVC, sin periféricos con mismo microorganismo, se inicia vancomicina. Describe rash (red man síndrome vs RAM) por lo que se suspende.
- ITU por *E. faecium* VAN B, resistente a linezolid, se cubre inicialmente con tigeciclina y luego con doxicilina ante quiebre de stock, completa 5 días.
- Nuevo hit, se inicia empírico Imipenem + amikacina + vancomicina. Se aísla *C. tropicalis* en orina, dado gravedad, se inicia anidulafungina (sospechando candidiasis invasora), luego se desescala a fluconazol. Se rescata CAET y HC positivos para *Serratia*, se mantiene terapia biasociada dado crecimiento recurrente. EcoTT sin hallazgos sugerentes de endocarditis.
- Febril, destaca arrastre de dos ramas de CVC (+) *Klebsiella* NDM, con HC periféricos negativos. Se rota a ceftazidima/avibactam + aztreonam por 10 días, con buena respuesta.
- NAVM bacteriémica por KPN NDM, se reinicia ceftazidima/avibactam + aztreonam, completando 10 días en UTIM.
- Por SDA se solicita Toxina CD (-). Se mantiene sin ATB, con resolución de cuadro diarreico.

4. Renal: Con necesidad de HD de forma intermitente desde el ingreso hasta el 30/12. Con recuperación de función renal posterior a manejo de interurrencias infecciosas, con vuelta a función renal habitual, con creatinina basal en 0.8.

5. Hematológico: Cursó con trombocitopenia secundaria a linezolid, ya resuelta. Presentó eosinofilia y rash obs RAM, ya resuelta. Anemia leve inflamatoria, en vigilancia con celldyn, estable.

6. Rehabilitación: rápida evolución, por planes:

- Motor: rehabilitación motora con kinesioterapia con buena evolución, llegando a buen control de tronco, deambula con asistencia técnica (burrito).
- FNA: cursa con trastorno deglutorio en manejo por fonoaudiología, progresando favorablemente hasta resolución.

Fecha Epicrisis : 09/03/2023 13:54

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 09-03-2023 13:54:36

Página 3 de 4

- Nutrición: se inicia nutrición enteral por SNG precozmente el 13/11/22, aumentando los aportes progresivamente según requerimientos. El 23/02/23 se logra retirar SNG y alimentar exclusivamente por vía oral, logrando metas de aportes nutricionales.
- Sin delirium ni LPP.

7. Endocrino: En imagen de ingreso destaca bocio difuso con nódulos tiroideos bilaterales, conocido. Evaluada por última vez septiembre/21, desde entonces no se ha realizado controles. Se difiere estudio para realizarlo de forma ambulatoria.

DIAGNÓSTICOS DE ALTA:

1. Crítica crónica
 - Miopatía paciente crítico
 - Usuaria TQT quirúrgica 06/01 -27/02
 - Trastorno de la deglución resuelto
2. Anemia leve normocítica
3. Trastorno de ansiedad generalizada
4. Resueltos:
 - NAVM bacteriémica por KPN NDM tratada
 - NAVM bacteriémica recurrente por Serratia tratada
 - Shock séptico de foco pulmonar + FOM resuelto
 - IOT 09/11/22 - 07/02/23
 - AKI KDIGO III anúrico con TRR resuelta
 - Trombocitopenia secundaria a linezolid resuelta
 - ITU por E. faecium VAN B tratada.
 - Sospecha de candidiasis invasora tratada

Diagnóstico de Egreso

Choque Séptico - Resuelto

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, normotensa, normocárdica, afebril, sin requerimientos de O2. Buena tolerancia oral, deambulando con ayuda técnica.

Plan Post Alta

* Es responsabilidad de paciente y familiares actualizar vacunas contra COVID 19. Paciente con altísimo riesgo de cuadro grave, lo que solo puede prevenirse con la vacunación.

Reposo relativo

Régimen hiposódico

Rehabilitación motora y respiratoria por Hospitalización domiciliaria.

Medicamentos:

Amlodipino 5 mg al día vía oral

Losartán 50 mg cada 12 horas vía oral

Carvedilol 3.125 mg cada 12 horas vía oral

Bromuro de ipatropio 2 puff SOS por aerocámara

Paracetamol 1 g vía oral SOS si dolor y/o fiebre, máximo cada 8 horas

Omeprazol 20 mg al día vía oral

Prednisona 5 mg al día vía oral

Setralina 50 mg al día vía oral

Risperidona 0.5 mg en la noche vía oral

Clonazepam 0.5 mg vía oral SOS en caso de angustia

Controles:

- Control con reumatología para manejo de artritis reumatoide. Solicitar hora en CDT Hospital Sótero del Río con esta epicrisis.
- Control con endocrinología para estudio de bocio multinodular. Solicitar hora en CDT Hospital Sótero del Río con esta epicrisis.

Fecha Epicrisis : 09/03/2023 13:54

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 09-03-2023 13:54:36

Página 4 de 4

- Control de Salud Mental en consultorio.
- Controles habituales en consultorio para manejo de enfermedades crónicas.

Consultar al servicio de urgencias si: fiebre $> 37.8^{\circ}$, dificultad para respirar, dolor al pecho mantenido, dolor insoportable que no ceda con paracetamol, en caso que lo estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Simon De La Maza Fontecilla

Médico Tratante (Staff)